

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América
Facultad de Medicina

Escuela Profesional de Enfermería



**“Conocimientos sobre alergias alimentarias en cuidadores de niños
de 6 a 24 meses en un Centro de Salud de Lima, 2026”**

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

AUTORA

Diana Katherine Ramos Vásquez

ASESORA

Mg. Gabriela Samillán Yncio

Lima, Perú

2026

Índice

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA

- 1.1 Planteamiento del problema (antecedentes, origen del problema y formulación del problema)
- 1.2 Objetivos
- 1.3 Justificación de la investigación
- 1.4 Limitaciones del estudio

CAPÍTULO II. BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS

- 2.1 Marco teórico (antecedentes, referente teórico)
- 2.2 Formulación de hipótesis
- 2.3 Metodología
 - 2.3.1 Tipo, método y diseño de investigación
 - 2.3.2 Población (criterios de inclusión y exclusión), muestra (tipo de muestreo)
 - 2.3.3 Variables
 - 2.3.4 Operacionalización de variables
 - 2.3.5 Técnicas e instrumentos (validez y/o confiabilidad)
 - 2.3.6 Plan de recolección, procesamiento y análisis estadístico de datos
 - 2.3.7 Consideraciones éticas. Consentimiento / asentimiento informado

CAPÍTULO III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- 3.1 Cronograma de trabajo
- 3.2 Presupuesto
- 3.3 Recursos disponibles

ANEXOS

- 1. Matriz de consistencia del proyecto
- 2. Matriz de consistencia del instrumento.
- 3. Cálculo del tamaño de muestra
- 4. Instrumento.
- 5. Cálculo de los valores finales de la variable
- 6. Consentimiento informado
- 7. Coeficiente de validez de contenido

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del problema

La alimentación complementaria es un proceso esencial en el desarrollo físico y nutricional del ser humano que se inicia a los seis meses cuando las necesidades de energía y nutrientes del mismo empiezan a ser superiores de lo que la leche materna les puede aportar (1). Esta transición es clave para asegurar el crecimiento físico y la salud del niño, y para proporcionar los nutrientes necesarios para su desarrollo cognitivo y motor. Sin embargo, la introducción de nuevos alimentos también plantea el riesgo de desarrollar alergias alimentarias, lo que puede tener repercusiones a largo plazo en la salud del niño.

Las alergias alimentarias son reacciones adversas del sistema inmunológico que ocurren cuando el cuerpo identifica un alimento como una amenaza, generando una respuesta inmune específica, ya sea mediada por la inmunoglobulina E (IgE), por células o por ambos (2), que pueden ser síntomas leves, como urticaria, hasta reacciones más graves como dificultad para respirar o anafilaxia. En los lactantes, estas suelen desarrollarse durante el proceso de la alimentación complementaria, que comienza a los seis meses de edad, cuando los niños empiezan a consumir alimentos sólidos además de la leche materna.

La introducción de alimentos potencialmente alergénicos como leche, huevo y maní, puede ser un desencadenante para el desarrollo de estas alergias debido a que estos alimentos son los principales causantes de alergias en lactantes y niños (3). El grupo particular de alérgenos causantes de la gran mayoría de alergias a los alimentos se denomina “los grandes ocho”, los cuales son: leche, huevo, pescado, marisco, nueces, cacahuete, trigo y soya (2).

Las alergias alimentarias en niños son un problema de salud pública que ha experimentado un aumento significativo en las últimas décadas, especialmente en los primeros años de vida. Estas son cada vez más frecuentes en el niño y preocupantes puesto que se observa un aumento en la prevalencia de alergias alimentarias en los primeros años de vida, llegando al 10% en niños preescolares (4).

En China la prevalencia de las alergias alimentarias en niños menores de dos años es del 11%, sin embargo, ésta decrece gradualmente durante la infancia (5). En Estados Unidos en cambio, el reporte del 2021 de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud del Centro Nacional de Estadísticas en Salud de los Estados Unidos, encontró que el 4,4% de niños menores de cinco años presentan alergia alimentaria, cifra que se incrementa conforme avanza la edad del menor (6).

A diferencia de los países desarrollados, donde se dispone de datos epidemiológicos consolidados, en América Latina la información sobre la prevalencia de alergias alimentarias sigue siendo limitada. En Colombia, por ejemplo, se ha observado un incremento progresivo en la prevalencia e incidencia durante los últimos años; en niños menores de cinco años, las estimaciones varían entre el 1 % y el 10 % (7). Por su parte, en Argentina se ha reportado una prevalencia de hasta un 10 % en niños en edad preescolar (8), lo que evidencia la magnitud del problema en las primeras etapas del desarrollo infantil.

Un estudio clínico realizado entre 2016 y 2018 en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), en Lima, encontró que el 40,9 % de los cuidadores sospechaba que su hijo presentaba alergia alimentaria; sin embargo, solo el 0,9 % fue confirmado médicamente (9). Esta discrepancia evidencia una brecha considerable entre la percepción de los cuidadores y el diagnóstico clínico real, lo que refuerza la necesidad de evaluar sus

conocimientos sobre esta condición. A pesar de su relevancia en la salud infantil, en el Perú no se cuenta con estudios epidemiológicos pediátricos de gran escala que permitan estimar con precisión la prevalencia de alergias alimentarias en esta población.

El rol del profesional de enfermería en la prevención del desarrollo de alergias alimentarias en niños menores de dos años resulta esencial, dado que su labor comprende funciones clave en la educación sanitaria y orientación a los cuidadores respecto a la introducción oportuna y adecuada de alimentos, la vigilancia de posibles manifestaciones clínicas de hipersensibilidad, la promoción de prácticas alimentarias seguras y brindar apoyo emocional. Asimismo, el personal de enfermería posee la competencia para identificar factores de riesgo predisponentes, tales como antecedentes familiares de enfermedades alérgicas, e instruir sobre la relevancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, puesto que confiere inmunidad activa y pasiva, a través de la maduración del sistema y también proporciona componentes bioactivos, como IgA e IgG secretoras, con un efecto profiláctico probado contra las alergias alimentarias (10). Además, el ejercicio profesional de la enfermería incluye la detección precoz de signos y síntomas sugestivos de reacciones alérgicas, permitiendo así una intervención oportuna y, en caso necesario, la derivación del paciente pediátrico hacia atención especializada para su evaluación diagnóstica y manejo integral (11).

El Centro de Salud San Luis, ubicado en el distrito de San Luis, el cual forma parte de la red de establecimientos de salud de Lima Centro. Este establecimiento brinda atención integral a la comunidad, con énfasis en la salud materno-infantil. A diferencia de otros centros de mayor afluencia, el Centro de Salud San Luis atiende un número reducido de niños de 6 a 24 meses. Esta característica permite un contacto más cercano con los cuidadores y una mayor posibilidad de profundizar en la comprensión de sus conocimientos y prácticas sobre la alimentación complementaria, lo

que hace del establecimiento un escenario adecuado para la recolección de información en este estudio.

Al respecto se entrevistó a algunas madres en el establecimiento acerca de su conocimiento sobre alergias alimentarias en niños de 6 a 24 meses, respondiendo entre otros lo siguiente: “Le di leche de vaca a mi hija y a los minutos vi que le empezaron a salir unas manchas rojas en su carita” ... “Yo ya le había dado leche a mi hijo, pero poquito, sino que la última vez le di puro y creo que por eso se puso mal” ... “Mi esposo es alérgico al pescado y yo creo que mi hijo también va a tener esa alergia por eso no le doy pescado todavía”.

De lo expuesto anteriormente se ha creído conveniente plantear la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre alergias alimentarias en cuidadores de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud San Luis, 2026?

1.2 Objetivos

Objetivo General:

Determinar el nivel de conocimientos sobre alergias alimentarias en cuidadores de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud San Luis, 2026.

Objetivos específicos

- Identificar los conocimientos sobre los principales alimentos causantes de alergias alimentarias en niños de 6 a 24 meses.
- Describir los conocimientos sobre signos y síntomas tempranos de la alergia alimentaria en niños de 6 a 24 meses.

1.3 Justificación de la investigación

Las alergias alimentarias en la primera infancia se han convertido en un problema emergente de salud pública a nivel mundial, debido a su creciente prevalencia y a las consecuencias clínicas, nutricionales, emocionales y económicas que conllevan. Esta condición representa una amenaza potencial para la vida del niño, pues puede desencadenar desde síntomas leves hasta reacciones anafilácticas graves que requieren atención médica urgente (3,2). En este contexto, conocer los factores relacionados a su aparición y control se vuelve crucial para la prevención y el manejo adecuado.

A pesar de que a nivel internacional se han desarrollado estrategias para reducir el riesgo de alergias alimentarias, como la introducción temprana y controlada de alimentos potencialmente alergénicos, su eficacia está estrechamente vinculada al grado de conocimiento que posean los cuidadores del niño. La evidencia indica que una correcta orientación desde los servicios de salud puede marcar la diferencia en la prevención de estas afecciones (10,11). Por ello, resulta de suma importancia generar evidencia científica local que permita orientar acciones educativas, preventivas y normativas desde un enfoque contextualizado.

Sin embargo, la efectividad de estas estrategias depende en gran medida del nivel de conocimiento que los cuidadores tengan sobre las alergias alimentarias. Un estudio transversal realizado reveló que la puntuación media de conocimiento de los padres sobre las alergias alimentarias era de 7.0 puntos, indicando un conocimiento limitado (13). Además, la falta de información adecuada puede llevar a prácticas ineficaces, como la eliminación innecesaria de alimentos de la dieta del niño, lo que podría afectar su nutrición y desarrollo (14).

En el contexto peruano, especialmente en Lima, se observa una escasa investigación sobre el nivel de conocimiento de los cuidadores respecto al desarrollo de alergias alimentarias en niños de 6 a 24 meses. Esta falta de datos limita el diseño de intervenciones educativas efectivas y la implementación de políticas públicas dirigidas a mejorar la salud infantil. Por lo tanto, este estudio busca llenar este vacío, proporcionando información valiosa que permita desarrollar estrategias de educación y prevención adaptadas a la realidad local.

1.4 Limitaciones del estudio

Una de las principales limitaciones identificadas durante el desarrollo del presente estudio fue la escasa disponibilidad de literatura científica centrada específicamente en la población de cuidadores de niños de 6 a 24 meses respecto a su conocimiento sobre alergias alimentarias. Si bien existen investigaciones relacionadas con alergias alimentarias en la infancia, la mayoría se enfocan en aspectos clínicos, prevalencia general o manejo desde el ámbito médico, dejando de lado el componente educativo y preventivo desde la perspectiva del cuidador.

Asimismo, la mayoría de investigaciones actuales provienen de contextos internacionales, cuyos resultados podrían no reflejar completamente la realidad sociocultural o sanitaria de la población peruana. Esta situación limita la posibilidad de realizar comparaciones directas con investigaciones locales en poblaciones similares, lo que resalta la necesidad de generar evidencia propia que contribuya a comprender y abordar esta problemática desde una mirada contextualizada.

CAPITULO II. BASES TEORICAS Y METODOLOGICAS

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Antecedente internacionales

Aljohani et al. (2025) en Arabia Saudita realizaron un estudio titulado “Investigación sobre la concienciación y las actitudes respecto a las alergias alimentarias entre los docentes de escuelas primarias: estado actual y oportunidades de mejora”. Se trató de una investigación cuantitativa, descriptiva y transversal, con una muestra de 383 docentes de educación primaria en Medina. La técnica de recolección consistió en una encuesta online basada en el Chicago Food Allergy Research Survey, evaluando el conocimiento, actitudes y creencias sobre alergias alimentarias. La conclusión del estudio fue:

“Este estudio reveló un buen conocimiento del profesorado sobre la identificación de alergias alimentarias y sus síntomas, así como su posible gravedad. Sin embargo, el estudio destacó una brecha significativa en el manejo. La mayoría mostró una actitud positiva hacia el aprendizaje sobre alergias alimentarias. Por lo tanto, es necesario implementar políticas y estrategias administrativas para facilitar el manejo de las alergias alimentarias en la escuela.” (15)

Taha et al. (2024) en Turquía llevaron a cabo el estudio “Nivel de conocimiento de los padres sobre el miedo a los nuevos alimentos y las alergias alimentarias”, publicado en Genel Tıp Dergisi. Fue una investigación cuantitativa, descriptiva y transversal, realizada durante el periodo 2022–2023 con una muestra de 341 padres de niños en edad escolar, seleccionados mediante muestreo aleatorio en escuelas primarias de Anatolia Central. Se utilizaron encuestas estructuradas y la escala Fear of New Food, junto con preguntas específicas sobre alergias alimentarias. La conclusión del estudio fue:

“Estos hallazgos tienen implicaciones notables para la práctica de la enfermería pediátrica, enfatizando la necesidad de intervenciones específicas para educar a los padres sobre las alergias alimentarias y promover prácticas seguras en el manejo de las reacciones alérgicas.” (16)

González Rodríguez (2024) en España, elaboró un estudio titulado “Alergia alimentaria: definición, síntomas, diagnóstico y tratamiento”, el cual consistió en una revisión narrativa con enfoque descriptivo. El documento abordó aspectos clave como la definición, clasificación,

síntomas, diagnóstico, tratamiento y epidemiología de las alergias alimentarias. El estudio concluye:

“Este aumento de la alergia alimentaria ha afectado a diferentes grupos de edad y géneros, lo cual plantea preocupaciones en términos de salud pública. Por lo tanto, es esencial continuar realizando estudios epidemiológicos para comprender mejor las causas subyacentes de este incremento y desarrollar estrategias eficaces de prevención, diagnóstico y manejo de las alergias alimentarias.” (17)

Kellogg et al. (2023) en Estados Unidos, realizaron un estudio titulado “Conocimientos, actitudes y creencias sobre las alergias alimentarias entre maestros de jardín de infantes a cuarto grado”. Se trató de una investigación cuantitativa, descriptiva y transversal. La muestra estuvo conformada por 42 docentes de nivel inicial y primaria, quienes completaron un cuestionario virtual basado en el Chicago Food Allergy Research Survey. El estudio concluye:

“Es fundamental aumentar la formación del profesorado en alergias alimentarias para garantizar entornos escolares seguros, así como desarrollar políticas educativas claras y protocolos de actuación frente a emergencias.” (18)

Laignelet y Hernández-Mantilla (2021) en Colombia realizaron un estudio titulado “Alergia alimentaria gastrointestinal: prevalencia, caracterización y costos en población pediátrica”. Se trató de una investigación retrospectiva, descriptiva y transversal, que incluyó tres fases metodológicas: revisión de las bases de datos RIPS y MIPRES (2015–2019) para estimar la prevalencia, revisión de historias clínicas para caracterización clínica y costos, y encuestas telefónicas para explorar la resolución de la enfermedad. La población evaluada estuvo conformada por menores de 5 años, agrupados por tramos etarios. La conclusión del estudio fue:

“Este es el estudio retrospectivo más grande en Colombia, lo que permite conclusiones locales que pueden ser comparadas con otros países.” (19)

Vera Cruz y Valero Cedeño (2023) realizaron una revisión documental de diseño descriptivo-explicativo, basada en 90 artículos publicados entre 2017 y 2022, con el objetivo de analizar la evidencia científica sobre diagnóstico y evolución de la alergia alimentaria en edad pediátrica. Así mismo, llegó a la siguiente conclusión:

“La prevalencia de alergia alimentaria en pacientes pediátricos es alta en países como Colombia, Cuba y Paraguay en Latinoamérica, destacando la necesidad de mayor atención y recursos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta afección en niños.”
(20)

2.1.2 Antecedentes nacionales

Rojas-Puell M. et al. (2022) realizaron un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo con el objetivo de determinar la frecuencia de alergia alimentaria en general, y de productos de consumo común oriundos del Perú, en estudiantes de medicina humana de una universidad privada del país. La muestra consistió en 355 estudiantes de entre 18 y 25 años, seleccionados mediante muestreo tipo “bola de nieve” a través de mensajería electrónica. Este estudio llegó a la siguiente conclusión:

“Existe una frecuencia de 9.3% de alergia alimentaria autorreportada, producida por productos de consumo común (oriundos del Perú) a nivel nacional.” (21)

Azurin Icaza y Gálvez Lemoine (2021) en Perú realizaron un estudio titulado “Alimentos que causan alergias alimentarias en pacientes de 06 meses a 18 años del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en Lima, Perú”. Fue un estudio cuantitativo, analítico y transversal, con una muestra de 113 padres o apoderados. El estudio concluyó:

“Las Alergias Alimentarias son una condición muy amplia por lo cual aún persisten algunas interrogantes. Es necesario realizar estudios multicéntricos con una población más global y en diferentes zonas del Perú ya que es un país multicultural con diversas costumbres alimenticias. Esto permitiría tener una visión más amplia de las alergias alimentarias en la población pediátrica,

además de permitir confirmar los resultados obtenidos en este estudio.” (22)

Muñoz Ana (2019) desarrolló y validó un cuestionario clínico titulado “Validación de un cuestionario basado en la anamnesis como herramienta diagnóstica de alergia alimentaria en niños”, basado en la anamnesis para el diagnóstico de alergia alimentaria en niños de 0 a 14 años que acudieron a un consultorio privado de gastro pediatría en Lima, Perú. El estudio observacional, prospectivo, de casos y controles, incluyó 51 casos con alergia alimentaria y 31 controles sin dicha condición. Así mismo, el estudio concluyó:

“Se encontró que los casos difirieron de los controles por la edad, siendo los casos más correspondientes a lactantes o escolares y los controles niños en edad escolar.” (23)

2.1.3 Referente teórico

2.1.3.1 Conocimientos sobre alimentos alérgenos

Alergia alimentaria

La alergia alimentaria es una reacción adversa del sistema inmunológico que ocurre de manera reproducible tras la ingesta, contacto o inhalación de un determinado alimento. En estos casos, el sistema identifica proteínas alimentarias como amenazas y produce una respuesta inmunitaria específica, inmediata o retardada, mediada por anticuerpos IgE o por células, lo cual la distingue claramente de las intolerancias alimentarias, que no involucran mecanismos inmunológicos (24). Las reacciones mediadas por IgE se caracterizan por su inicio rápido (generalmente entre minutos y dos horas), y pueden involucrar múltiples sistemas corporales: cutáneo (urticaria, angioedema), gastrointestinal (dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea), respiratorio (broncoespasmo, estridor, rinitis) y cardiovascular (hipotensión, síncope).

En casos severos, pueden desencadenar anafilaxia, una emergencia médica sistémica potencialmente letal (24,25).

Componente genético

El componente genético juega un papel central en el desarrollo de alergias alimentarias. Los niños con antecedentes familiares de alergias, tanto alimentarias como otras condiciones alérgicas como asma o eczema, tienen una mayor predisposición a desarrollar estas alergias. La revisión de Suaini et al. (26) destacó que ciertos genes relacionados con la respuesta inmune y la regulación de la inflamación pueden predisponer a los niños a desarrollar alergias alimentarias, aunque no todos los niños con predisposición genética necesariamente desarrollan estas alergias, lo que sugiere que los factores ambientales también tienen un papel importante en su aparición.

Alérgenos más frecuentes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los alimentos que comúnmente provocan alergias alimentarias en la infancia incluyen la leche de vaca, el maní, los huevos, el trigo, los mariscos, el pescado, la soja y los frutos secos (27), conocidos internacionalmente como “los grandes ocho”.

Leche de vaca

Es la alergia más frecuente en menores de 1 año. Involucra una reacción inmunológica a proteínas como la caseína, alfa-lactoalbúmina y beta-lactoglobulina. Las manifestaciones pueden ser cutáneas, gastrointestinales o respiratorias. Aunque muchos lactantes superan esta alergia antes de los 3 años, es una causa común de consultas pediátricas en la etapa de lactancia (28).

Huevo de gallina

Es la segunda causa más común de alergia en menores de 5 años. Las principales proteínas implicadas son la ovoalbúmina y el ovomucoide, esta última altamente resistente al calor. La alergia suele remitir en la infancia, pero requiere una vigilancia estricta durante la introducción del alimento (29).

Maní

El maní provoca reacciones graves y persistentes. Su consumo en niños sensibilizados puede desencadenar anafilaxia. Los alérgenos Ara h 1, h 2 y h 3 son los principales responsables, siendo Ara h 2 el más asociado con reacciones severas. A diferencia de otras alergias, suele mantenerse en la edad adulta (30).

Frutos secos

Incluyen nueces, almendras, avellanas, pistachos, entre otros. Estas alergias pueden desarrollarse en la infancia y, al igual que el maní, tienden a ser permanentes. Son una causa común de reacciones graves y su evitación implica un monitoreo estricto de etiquetas alimentarias (31).

Pescado

Los niños pueden desarrollar alergia a proteínas musculares como la parvalbúmina. A menudo se presenta más tarde en la infancia, pero en casos con antecedentes familiares puede iniciarse antes. La reacción suele persistir toda la vida y se asocia con sensibilización cruzada entre distintas especies de pescado (32).

Mariscos

Incluyen camarones, langostinos, cangrejos y moluscos. Su principal alérgeno es la tropomiosina, que resiste la cocción. Aunque su

prevalencia es más alta en adultos, también se reportan casos en la infancia temprana, especialmente en poblaciones costeras. Su consumo debe evitarse por completo en niños diagnosticados (33).

Trigo

La proteína del trigo (principalmente la gliadina) puede provocar reacciones alérgicas distintas a la enfermedad celíaca. En menores de 2 años, la alergia al trigo puede causar urticaria, vómitos o incluso síntomas respiratorios. Aunque en muchos casos remite con la edad, requiere seguimiento (34).

Soya

La soya es una legumbre común en fórmulas infantiles. Las proteínas Gly m 5 y Gly m 6 son las más alergénicas. Aunque muchas alergias a soya se resuelven en los primeros años, algunos niños presentan reacciones cruzadas con otras legumbres, como el maní (35).

2.1.3.2 Conocimientos sobre signos y síntomas tempranos

Signos y síntomas

Las reacciones alimentarias mediadas por IgE suelen presentarse entre los primeros 5 minutos y 2 horas posteriores a la ingestión del alérgeno (29). Pueden afectar uno o más sistemas del organismo y su reconocimiento oportuno es crucial para evitar desenlaces graves como la anafilaxia.

- Cutáneo: Síntomas como urticaria, angioedema y eritema ocurren en hasta el 90 % de los casos, y en ocasiones son los únicos indicativos de una reacción alérgica aguda (35).

- Gastrointestinal: Incluyen náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, presentes en aproximadamente el 30–45 % de las reacciones IgE mediadas (29).
- Respiratorio: Se manifiestan como sibilancias, estridor, tos persistente, dificultad para respirar o broncoespasmo, contabilizándose en más del 70 % de los eventos alérgicos (29,35).
- Cardiovascular: Se caracterizan por taquicardia, hipotensión, síncope y, en casos extremos, colapso cardiovascular, especialmente cuando la reacción evoluciona a anafilaxia (29,35).
- Anafilaxia: Reacción sistémica severa que combina síntomas cutáneos con respiratorios o cardiovasculares, y que puede progresar rápidamente a choque si no se actúa de inmediato (29,35).
- Síndrome de alergia oral (OAS): Características incluyen prurito o escozor en boca y garganta tras ingerir alimentos crudos, debido a reactividad cruzada con pólenes; se reporta en un 5–10 % de los niños alérgicos (36).

Prevención

En cuanto a la prevención de las alergias alimentarias, diversos estudios han sugerido que los padres deben ser capaces de identificar los primeros signos de una reacción alérgica. Kattan et al. (37) destacaron que la identificación temprana de los síntomas y la intervención inmediata pueden reducir considerablemente los riesgos asociados con las alergias alimentarias. Además, el retraso en la introducción de alimentos potencialmente alérgenos ha sido relacionado con un aumento en la sensibilización a esos mismos alimentos, lo que refuerza la importancia de una introducción temprana y bien informada.

El conocimiento de los padres sobre las alergias alimentarias es crucial para el manejo adecuado de estas afecciones. Diversos estudios han evidenciado que los padres con un nivel adecuado de conocimiento sobre

los alérgenos más comunes, los síntomas de una reacción alérgica y las medidas de prevención tienen mayor capacidad para tomar decisiones informadas sobre la alimentación de sus hijos. Mckenzie et al. (38) confirmaron que el conocimiento de los padres sobre las alergias alimentarias puede influir directamente en sus decisiones relacionadas con la dieta de sus hijos, ayudando a prevenir reacciones adversas. La información proveniente de profesionales de salud, es esencial para que los padres comprendan cómo identificar los alimentos alérgenos y cómo manejar las reacciones alérgicas de forma adecuada. Sin embargo, la falta de conocimiento o la desinformación pueden generar prácticas erróneas que aumentan el riesgo de reacciones alérgicas graves.

Modelo de Salud de Nola Pender

Desde la perspectiva teórica, el Modelo de Salud de Pender (39), plantea que el conocimiento y la motivación de los padres influyen directamente en sus comportamientos relacionados con la salud de sus hijos. De acuerdo con este modelo, los factores internos, como la percepción de los riesgos para la salud, y los factores externos, como la influencia de los profesionales de salud y las experiencias previas, determinan las conductas relacionadas con la alimentación. Este modelo es relevante en el contexto de las alergias alimentarias, ya que resalta cómo el conocimiento de los padres hacia los alérgenos puede influir en sus decisiones sobre qué alimentos incluir o evitar en la dieta de sus hijos.

De acuerdo con este modelo, los factores internos, como la percepción de los riesgos para la salud, y los factores externos, como la influencia de los profesionales de la salud, la familia y las experiencias previas, determinan las conductas relacionadas con la alimentación. En el caso de las alergias alimentarias, este marco teórico adquiere especial relevancia, ya que explica cómo el nivel de conocimiento que poseen los cuidadores respecto a los alérgenos puede influir en la prevención de la exposición, en la selección de alimentos y en la toma de decisiones rápidas ante una reacción adversa (40).

Asimismo, el modelo enfatiza la importancia de las variables interpersonales y situacionales, reconociendo que los padres no actúan de manera aislada, sino en un contexto donde intervienen las recomendaciones médicas, las normas sociales y el acceso a la información confiable. En consecuencia, el conocimiento y las actitudes frente a las alergias alimentarias no solo repercuten en la protección del niño frente a episodios adversos, sino también en el desarrollo de hábitos de alimentación seguros y sostenibles a lo largo del tiempo (41).

2.1.4 Definición operacional de términos

- **Conocimientos:** Hace referencia al conjunto de información, creencias, habilidades y comprensión que posee una persona sobre un tema específico. En esta investigación, se refiere al nivel de información que tienen los cuidadores sobre alergias alimentarias, sus causas, síntomas, prevención y manejo.
- **Alergias alimentarias:** Son reacciones adversas del sistema inmunológico que ocurren tras la ingesta de determinados alimentos. Se caracterizan por la producción de anticuerpos, generalmente de tipo inmunoglobulina E (IgE), que desencadenan síntomas que pueden variar desde leves (urticaria, vómitos) hasta graves (anafilaxia).
- **Cuidadores:** Personas responsables del cuidado directo y cotidiano del niño. Incluye principalmente a madres, padres, abuelos u otros familiares, así como a cuidadores no parentales que se encargan de la alimentación, higiene y protección del menor.
- **Niños de 6 a 24 meses:** Grupo etario que abarca de los seis a veinticuatro meses de edad. Es una etapa crítica en el desarrollo infantil, caracterizada por la introducción de la alimentación complementaria y la posible aparición de reacciones alérgicas a nuevos alimentos.

2.2 Hipótesis

Según Hernández Sampieri dado que el diseño del estudio es no experimental, no hay manipulación de variables, y no se establece relación de causa y efecto, no procede la hipótesis (42).

2.3 Metodología

2.3.1 Tipo, método y diseño de investigación

El presente estudio es de tipo cuantitativo, porque utiliza la recolección y análisis de datos numéricos para responder al problema planteado. El método es descriptivo, ya que busca detallar los conocimientos que poseen los cuidadores sobre alergias alimentarias en niños de 6 a 24 meses. El diseño es no experimental, transversal, debido a que no se manipulan variables y la información se recolecta en un único momento.

2.2.2 Población

Población

La población estará conformada por 654 cuidadores de niños de 6 a 24 meses de edad, registrados en el padrón nominal del Centro de Salud San Luis, distrito de Lima, durante el año 2025.

Criterios de inclusión

- Cuidadores que tengan a su cargo niños entre 6 a 24 meses.
- Cuidadores de niños de 6 a 24 meses registrados en el padrón nominal del Centro de Salud San Luis.
- Cuidadores mayores de 18 años.
- Cuidadores que acepten participar voluntariamente y firmen el consentimiento informado.

Criterios de exclusión

- Cuidadores que no completen el cuestionario en su totalidad.
- Cuidadores que presenten dificultades de comunicación en idioma español que impidan la adecuada comprensión del instrumento.
- Cuidadores que presenten limitaciones cognitivas evidentes que dificulten la comprensión del cuestionario.

Muestra

El tamaño de muestra teórico se calculó mediante la fórmula para población finita, considerando una población de 654 niños, un nivel de confianza del 95%, una proporción esperada de 0.5 y un error máximo admisible del 5%, obteniéndose un tamaño muestral de 242 cuidadores.

La selección de los participantes se realizará mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, incluyendo a los cuidadores que acudan al Centro de Salud San Luis durante el periodo de recolección de datos de dos meses consecutivos y que cumplan con los criterios de inclusión.

El tamaño final de la muestra dependerá de la disponibilidad y afluencia real de los participantes durante el periodo de estudio, lo cual constituye una limitación operativa propia del contexto asistencial.

2.3.3 Variables

Variable principal: Conocimiento sobre alergias alimentarias. Variable cualitativa de tipo ordinal, donde los resultados se expresarán en niveles de conocimiento (bajo, medio y alto) que guardarán un orden jerárquico.

2.3.4 Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Dimensiones	Definición de dimensión	Indicadores	Valor final de la variable
Conocimientos de alergias alimentarias	Información y/o saberes adquiridos a través de experiencias o estudios respecto a las manifestaciones clínicas de las alergias alimentarias que son las respuestas inmunológicas del organismo frente a un alérgeno presente en algún alimento.	Alimentos alergénicos	Aquellos alimentos que contienen proteínas capaces de desencadenar una respuesta inmunológica adversa en personas susceptibles, especialmente en niños pequeños.	• Concepto de alergia alimentaria • Conocimiento sobre factores genéticos en la alergia • Identificación de los alérgenos más frecuentes	Alto Medio Bajo

		Signos y síntomas	Son las manifestaciones clínicas que presenta una persona cuando sufre una condición o enfermedad. Los síntomas son percepciones subjetivas referidas por el paciente o cuidador mientras que los signos son observables y medibles por un profesional de salud.	• Identificación de síntomas cutáneos • Identificación de síntomas gastrointestinales • Identificación de síntomas respiratorios • Reconocimiento de signos de anafilaxia • Conocimientos de medidas preventivas	Alto Medio Bajo
Definición operacional	Información que refieren los cuidadores de niños de 6 a 24 meses sobre los alimentos alergénicos más comunes y los signos y síntomas de las alergias alimentarias que será valorado a través de un cuestionario.				

2.3.5 Técnicas e instrumentos

Para la recolección de datos se utilizará la técnica de encuesta, la cual permitirá obtener información directa de los cuidadores sobre sus conocimientos respecto a alergias alimentarias en niños de 6 a 24 meses, asistentes al centro de salud seleccionado.

El instrumento que se aplicará será un cuestionario de conocimientos adaptado por la investigadora, a partir de instrumentos validados previamente y literatura científica actualizada sobre alergias alimentarias en la infancia y adecuado al contexto local.

El cuestionario tiene como finalidad medir la variable: conocimiento sobre alergias alimentarias en cuidadores de niños de 6 a 24 meses. Está conformado por 16 ítems de opción múltiple con una sola respuesta correcta, organizados en dos dimensiones:

- Alimentos alergénicos, conformada por 6 ítems.
- Signos y síntomas de alergia alimentaria, conformada por 10 ítems.

La escala de medición es dicotómica, asignándose un punto (1) a cada respuesta correcta y cero (0) puntos a las respuestas incorrectas. El puntaje total permitirá clasificar el nivel de conocimiento de los cuidadores sobre alergias alimentarias.

Para la validez de contenido, el instrumento fue sometido a juicio de expertos, incluyendo una licenciada en enfermería y dos licenciadas en nutrición con experiencia en temas relacionados con la investigación. Ellas evaluaron la claridad y relevancia de cada ítem. Las observaciones fueron consideradas y se realizaron los ajustes necesarios.

2.3.6 Plan de recolección, procesamiento y análisis estadístico de datos

La recolección de datos se llevará a cabo de forma directa en los diferentes servicios del Centro de Salud San Luis, tales como CRED, consultorio de pediatría, inmunizaciones y otros servicios afines, donde acuden los cuidadores de niños de 6 a 24 meses. La investigadora explicará de manera clara y sencilla a los cuidadores participantes el objetivo del estudio, garantizando un ambiente cómodo, seguro y privado durante la aplicación del cuestionario. El cuestionario será aplicado a los participantes que cumplan con los criterios de inclusión durante el periodo establecido para el estudio.

El procesamiento de los datos se efectuará mediante el programa Microsoft Excel. En primer lugar, se procederá a la codificación de las variables, asignando valores numéricos que permitan organizar y sistematizar la información de manera adecuada. Posteriormente, se realizará el ingreso de los datos y su depuración, verificando que no existan errores de digitación y que los valores registrados se encuentren dentro de los rangos establecidos. De esta forma, se garantizará la calidad y confiabilidad de la base de datos obtenida.

El análisis estadístico de los datos se realizará utilizando el programa Microsoft Excel. Para ello, se aplicará estadística descriptiva. Asimismo, la información se organizará en tablas y gráficos que facilitarán la interpretación de los hallazgos y permitirán responder a los objetivos planteados en la investigación.

2.3.7 Consideraciones éticas

La presente investigación se desarrollará respetando los principios éticos fundamentales de la bioética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, conforme a lo establecido en la Declaración de Helsinki y el Reglamento de Ensayos Clínicos en Seres Humanos del Ministerio de Salud del Perú.

Previo a la recolección de datos, se gestionará la autorización del establecimiento de salud donde se ejecutará el estudio. A cada participante se le brindará información clara sobre el propósito de la investigación, la voluntariedad de su participación, la confidencialidad de sus respuestas y su derecho a retirarse en cualquier momento sin que ello afecte la atención recibida.

Se elaboró un consentimiento informado, que será leído y firmado por los cuidadores participantes, asegurando que su decisión de participar sea libre y voluntaria. Como el estudio no implicará intervención directa en los niños, no se requerirá asentimiento infantil; sin embargo, se garantizará en todo momento la protección de su identidad e integridad.

Los datos serán anonimizados y codificados, y se almacenarán de forma segura, con acceso restringido solo a la investigadora. La información obtenida se utilizará exclusivamente con fines académicos, y los resultados se presentarán de manera agregada, sin identificar a ningún participante.

El protocolo de investigación fue presentado ante el Comité de Ética correspondiente para su revisión y aprobación, asegurando el cumplimiento de las normativas éticas vigentes en investigaciones con seres humanos. Se obtuvo la aprobación respectiva.

CAPITULO III: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Cronograma de trabajo

[illegible]

3.2 Presupuesto

BIENES	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Paquete de hojas Bond	1	S/. 15	S/. 15
Lapiceros	6	S/. 1	S/. 6
Fólderes	7	S/. 5	S/. 35
Corrector	3	S/. 2.50	S/. 7.50
Engrapador	1	S/. 5	S/. 5
Caja de grapas	1	S/. 3	S/. 3
USB	1	S/. 20	S/. 20
SERVICIOS			
Movilidad	-	S/. 100	S/. 100
Internet	5	S/. 50	S/. 250
Luz	4 meses	S/. 50	S/. 200
TOTAL			S/. 641.50

3.3 Recursos disponibles

3.3.1 Recursos humanos:

- Investigadora: Diana Katherine Ramos Vásquez
- Asesora: Mg. Gabriela Samillán Yncio

3.3.2 Recursos materiales:

Para el presente proyecto se requerirá hojas bond, lapiceros, engrapadora, caja de grapa, impresora y tinta

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud. Alimentación del lactante y del niño pequeño [Internet]. Ginebra: OMS; 2023 [citado 6 abr 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding>
2. Reyes-Pavón D, Jiménez M, Salinas E. Fisiopatología de la alergia alimentaria. Rev Alerg Mex [Internet]. 2020 mar [citado 9 abr 2025];67(1):34-53. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-91902020000100034&lng=es
3. Vera C, Valero N. Diagnóstico y evolución de la alergia alimentaria en la edad pediátrica. Rev Polo Conoc [Internet]. 2023 abr [citado 9 abr 2025];8(4):66-91. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9152207>
4. Maidana PA, González Ledesma AI, Martínez PA, Méndez LE. Alergia alimentaria en niños: una revisión bibliográfica. Rev Investig Cient Technol [Internet]. 2024 [citado 9 abr 2025];8(1):49-60. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9664069>
5. Huang Z, Gan H, Huang Y, Zhu H, Liu T, Chen T, et al. Risk assessment of allergic diseases among preschool children in Guangzhou, China: a cross-sectional study. J Asthma Allergy. 2023; 16:501–513. [citado 15 abr 2025]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370569560_Risk_Assessment_of_Allergic_Diseases_Among_Preschool_Children_in_Guangzhou_China_A_Cross-Sectional_Study
6. Jackson SL, Brindley MF, Cai B, Akinbami LJ. Food allergy among children in the United States, 2021. NCHS Data Brief [Internet]. 2023 Jan [citado 15 abr 2025];(461):1-8. Disponible en: <https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db461.htm>
7. Laignelet-Hernández H, Hernández-Mantilla N. Alergia alimentaria gastrointestinal: prevalencia, caracterización y costos directos en un centro de remisión en Bogotá. Rev Colomb Gastroenterol [Internet]. 2022

- [citado 15 abr 2025];37(2):145–154. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/3377/337772258003/html/>
8. Burgos F, Herrero T, Martínez J, Tabacco O, Vinderola G. Inmunomodulación con bióticos y alergia alimentaria en pediatría. Arch Argent Pediatr [Internet]. 2022;120(4):274–280. [citado 16 abr 2025]. Disponible en: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2022/v120n4a11.pdf>
 9. Cuadro J, Ríos M. Alergia alimentaria percibida por padres de niños que acudieron a un centro pediátrico de alergias en Lima, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica [Internet]. 2018 [citado 16 abr 2025];35(4):708–10. Disponible en: <https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2018.v35n4/708-710/es/>
 10. Koukou Z, Papadopoulou E, Panteris E, Papadopoulou S, Skordou A, Karamaliki M, et al. The effect of breastfeeding on food allergies in newborns and infants. Children (Basel) [Internet]. 2023 [citado 16 abr 2025];10(6):486. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3390/children10061046>
 11. Simeone S, Ruotolo G, Della Polla G, Pelullo CP, Angelillo IF. Impact of school nurses on children with food allergies: a comprehensive review. Children (Basel) [Internet]. 2025 [citado 16 abr 2025];12(2):201. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11854810/pdf/children-12-00201.pdf>
 12. Zamudio-Ruiz M, Rosell-Ortiz J, Martínez-Torres J, Colchado J, Sánchez P, Suárez V. Food allergy and anaphylaxis management in Latin American school settings: a regional survey of school staff knowledge, attitudes, and practices. BMC Public Health [Internet]. 2024 Apr 17 [citado 18 abr 2025];24:939. Disponible en: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-20139-y>
 13. Dantzer JA, Wood RA. The overuse of food allergy panels in the diagnosis of food allergy. Ann Allergy Asthma Immunol [Internet]. 2023 [citado el 21

- de abr de 2025];131(2):165–71. Disponible en: [https://www.annallergy.org/article/S1081-1206\(23\)00268-5/fulltext](https://www.annallergy.org/article/S1081-1206(23)00268-5/fulltext)
14. Aljohani AH, Alshamani AM, Aljohani AA, Almohammadi AS, Alharbi BS, Altarjami DF, Alsaedi RS. Investigating food allergy awareness and attitudes among teachers in primary schools: current status and opportunities for enhancement [Internet]. *Front Pediatr*. 2025 Jan 8 [citado 21 abr 2025]; 12:1471494. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39845454/>
15. Taha N, İyigün M, Akıncı A. Parental awareness and attitudes about food allergies in children [Internet]. *Genel Tıp Dergisi*. 2022 Jun [citado 21 abr 2025];32(2):45-51. Disponible en: <https://dergipark.org.tr/en/pub/geneltip/article/1425054>
16. González Rodríguez A. Alergia alimentaria: definición, síntomas, diagnóstico y tratamiento [Internet]. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; 2024 [citado 21 de abr de 2025]. Disponible en: <https://burjcdigital.urjc.es/server/api/core/bitstreams/76c27cd4-34c1-418d-86dc-f14354e056b1/content>
17. Kellogg R, Lee SY, Wilson K, Radler D. Food Allergy Knowledge, Attitudes, and Beliefs Among Kindergarten Through Fourth Grade Teachers [Internet]. *School Nutrition Association Journal*. 2023 [citado 21 de abr de 2025]; Disponible en: <https://schoolnutrition.org/es/journal/fall-2023-food-allergy-knowledge-attitudes-and-beliefs-among-kindergarten-through-fourth-grade-teachers/>
18. Laignelet L, Hernández-Mantilla NR. Alergia alimentaria gastrointestinal: prevalencia, caracterización y costos en población pediátrica. *Rev Col Gastroenterol* [Internet]. 2021 [citado 21 abr 2025];36(4):376–84. Disponible en: <https://revistagastrocol.com/index.php/rcg/article/view/789>
19. Vera Cruz CP, Valero Cedeño NJ. Diagnóstico y evolución de la alergia alimentaria en la edad pediátrica. *Polo del Conocimiento* [Internet]. 2023 Abr [citado 21 abr 2025];8(4):66–91. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9152207>
20. Rojas-Puell María J., Salazar-Gastelu Danna, Runzer-Colmenares Fernando M., Medina-Hernández Alejandra. Frecuencia de alergia alimentaria en estudiantes de medicina humana de una universidad

- privada. Rev. alerg. Méx. [revista en la Internet]. 2022 Sep [citado 22 abr 2025] ; 69(3): 119-124. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-91902022000300119&lng=es.
21. Azurin Icaza JA, Gálvez Lemoine HG. Alimentos que causan alergias alimentarias en pacientes de 06 meses a 18 años del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en Lima, Perú [Internet]. Lima: Univ Científica del Sur; 2021 [citado 22 abr 2025]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12805/1656>
22. Muñoz Urribarri AB. Validación de un cuestionario basado en la anamnesis como herramienta diagnóstica de alergia alimentaria en niños [Tesis de licenciatura en Internet]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2019 [citado 22 abr 2025]. Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/cd40597f-b4f1-4865-b340-fdf8f82f1443/content>
23. Boyce JA, Assa'ad A, Burks AW, Jones SM, Sampson HA, Wood RA, et al. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-Sponsored Expert Panel [Internet]. J Allergy Clin Immunol. 2010 Dec;126(6 Suppl):S1–58 [citado 24 abr 2025]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21134568/>
24. Bégin P, Wasserman S, Protudjer JLP, Jeimy S, Watson W. Immunoglobulin E (IgE)–mediated food allergy [Internet]. Allergy Asthma Clin Immunol. 2024 Dec 30;20(Suppl 3):75 [citado 24 abr 2025]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39736801/>
25. Suaini NH, Lee YK, Ariffin SH, Wong KK, Chong SY, Chai PF, et al. Genetic predisposition and risk factors of food allergy: A systematic review. Allergol Int [Internet]. 2022 Apr [citado 5 may 2025];71(2):173–82. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.alit.2021.10.006>
26. Tanno LK, Demoly P. Food allergy in the World Health Organization's International Classification of Diseases (ICD-11). Pediatr Allergy Immunol [Internet]. 2022 Nov;33(11):e13882. [citado 5 may 2025]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36433855/>
27. Hochwallner H, Schulmeister U, Swoboda I, Focke-Tejkl M, Reisinger J, Wild C, et al. Microarrayed cow's milk allergens for the diagnosis of cow's

- milk allergy. Clin Chem [Internet]. 2010 Nov;56(11):1673–81. [citado 5 may 2025]. Disponible en: <https://academic.oup.com/clinchem/article/56/11/1673/5624276>
28. Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management. J Allergy Clin Immunol [Internet]. 2018 Jan;141(1):41–58. [citado 5 may 2025]. Disponible en: [https://www.jacionline.org/article/S0091-6749\(17\)31525-0/fulltext](https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(17)31525-0/fulltext)
29. Sicherer SH, Sampson HA. Peanut allergy: emerging concepts and approaches for an apparent epidemic. J Allergy Clin Immunol [Internet]. 2007 Jun;120(3):491–503. [citado 5 may 2025]. Disponible en: [https://www.jacionline.org/article/S0091-6749\(07\)00752-5/fulltext](https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(07)00752-5/fulltext)
30. Khatibi A, Soheilipour F, Ardestani ME, Moradi M. Food allergy: A comprehensive review of fish and seafood allergy. Int J Prev Med [Internet]. 2022 Feb;13:19. [citado 5 may 2025]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9090669/>
31. Yu CJ, Lin CY. Shellfish allergy: A comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol [Internet]. 2021 Dec;61(3):303–16. [citado 5 may 2025]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33993368/>
32. Cianferoni A. Wheat allergy: Diagnosis and management. J Asthma Allergy [Internet]. 2021 May 10; 14:141–51. [citado 6 may 2025]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33981714/>
33. Savage J, Johns CB. Food allergy: Epidemiology and natural history. Immunol Allergy Clin North Am [Internet]. 2015 Feb;35(1):45–59. [citado 6 may 2025]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25459576/>
34. Nowak-Wegrzyn A, Assa'ad AH, Bahna SL, Bock SA, Sicherer SH, Teuber SS. Non-IgE-mediated gastrointestinal food allergy. J Allergy Clin Immunol [Internet]. 2015;135(5):1114–24. [citado 6 may 2025]. Disponible en: [https://www.jacionline.org/article/S0091-6749\(14\)01741-4/fulltext](https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(14)01741-4/fulltext)
35. Palomares JC, et al. Clinical manifestations of oral allergy syndrome in pediatric populations. Clin Rev Allergy Immunol [Internet]. 2020;59(3):412–24. [citado 6 may 2025]. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12016-019-0873-4>

36. Kattan JD, Sicherer SH, Burks AW, Jones SM, Sampson HA. Optimizing the diagnosis of food allergy: focus on oral food challenges and early intervention strategies. *Immunol Allergy Clin North Am* [Internet]. 2015 Nov;35(4):61–75. [citado 7 may 2025]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26589342/>
37. Mckenzie C, Sayre PH, Roberts G, Lawson K, Bahnson HT, Radulovic S, et al. Parental knowledge and attitudes toward food allergies: a cross-sectional study on determinants and educational needs. *BMC Public Health* [Internet]. 2024 Jan;24:20139. [citado 6 may 2025]. Disponible en: <https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-024-20139-y>
38. Pender NJ. *Health Promotion in Nursing Practice*. 3ª ed. Stamford (CT): Appleton & Lange; 1996.
39. Melo C, Silva L, Carvalho A. Application of the Health Promotion Model to nursing practice: integration into primary care interventions. *Rev Enferm*. 2015;23(4):239-46. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11913135/>
40. Souza R, Lima F, Pereira T. Components of Nola Pender's Health Promotion Model: a theoretical analysis. *Rev Bras Enferm*. 2018;71(2):112-9. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/reben/a/3q4xxH7VBQhg37bRT4ZZP3y/>
41. Hernández-Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. *Metodología de la investigación*. México (DF): McGraw-Hill Interamericana; 2010. Cap.7: Diseños no experimentales de investigación.

ANEXO

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	BASES TEÓRICAS	TIPO, MÉTODO, DISEÑO	POBLACIÓN, MUESTRA, CRITERIOS DE SELECCIÓN	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
¿Cuál es el nivel de conocimiento de los cuidadores sobre el desarrollo de alergias alimentarias en niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud San Luis, 2026?	Objetivo General: Determinar el nivel de conocimientos sobre alergias alimentarias en los cuidadores de niños de 6 a 24 meses en un centro de salud en Lima, 2026	Según Hernández Sampieri dado que el diseño del estudio es no experimental, no hay manipulación de variables, y	1. Conocimientos sobre alimentos alérgenos ▪ Alergia alimentaria ▪ Componente genético ▪ Alérgenos más frecuentes (leche de	El presente estudio es de tipo cuantitativo, porque utiliza la recolección y análisis de datos numéricos para responder al problema	Población Cuidadores de niños de 6 a 24 meses que asisten a controles de crecimiento y desarrollo (CRED) en un centro de salud	Para la recolección de datos se utilizará la técnica de encuesta, la cual permitirá obtener información directa de los cuidadores sobre sus conocimientos respecto a

	Objetivos Específicos: - Identificar los conocimientos sobre los principales alimentos causantes de alergias alimentarias en niños de 6 a 24 meses - Describir los conocimientos sobre signos y síntomas tempranos de las alergias alimentarias en niños de 6 a 24 meses	no se establece relación de causa y efecto, no procede la hipótesis	vaca, huevo de gallina, maní, frutos secos, pescado, mariscos, trigo y soya) 2. Conocimientos sobre signos y síntomas tempranos - Signos y síntomas - Prevención	planteado. El método es descriptivo, ya que busca detallar los conocimientos que poseen los cuidadores sobre alergias alimentarias en niños de 6 a 24 meses. El diseño es no experimental, transversal, debido a que no se	de Lima durante el año 2026. Muestra Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando a los cuidadores que acudieron al centro de salud durante el periodo de recolección de datos y que cumplieron con los criterios	alergias alimentarias en niños de 6 a 24 meses, asistentes al centro de salud seleccionado. El instrumento que se aplicará será un cuestionario de conocimientos adaptado por la investigadora, a partir de instrumentos validados previamente y literatura
--	---	--	---	---	---	---

				manipulan variables y la información se recolecta en un único momento.	establecidos. La muestra estuvo constituida por la población censal Criterios de inclusión • Cuidador es que tengan a su cargo niños entre 6 a 24 meses. • Cuidador es que acepten participar voluntariamente y firmen el	científica actualizada sobre alergias alimentarias en la infancia y adecuado al contexto local.
--	--	--	--	---	--	--

					consentimiento informado. Criterios de exclusión • Cuidador es que no se comuniquen fluidamente en español • Cuidador es que no sepan leer ni escribir • Cuidador es con trastornos	
--	--	--	--	--	--	--

					cognitivos que dificulten la comprensión del cuestionario	
--	--	--	--	--	--	--

ANEXO 2: MATRIZ DEL INSTRUMENTO

DIMENSIÓN	INDICADOR	PREGUNTAS (ÍTEMS)
1. Alimentos alergénicos	• Concepto de alergia alimentaria • Conocimiento sobre factores genéticos en la alergia • Identificación de los alérgenos más frecuentes	1. Usted considera que una alergia alimentaria se define como: A. Una infección que se presenta en el estómago por algunos alimentos B. Una reacción del sistema inmunológico frente a ciertos alimentos C. Un problema que ocurre al digerir determinados tipos de alimentos D. No conozco 2. Cuando un niño tiene alergias alimentarias, cree usted que se manifiesta por: A. Solo siente un poco de hambre, cansancio y sueño en algunos momentos B. Puede presentar síntomas como ronchas, vómitos o dificultad para respirar C. Puede presentar molestias leves que parecen poco importantes D. No conozco 3. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que se asocia más frecuentemente al desarrollo de alergias alimentarias? A. El clima de la región donde vive habitualmente el niño B. El nivel de actividad física que realiza diariamente el niño C. La predisposición genética y antecedentes familiares

		D. No conozco 4. ¿Cree usted que el antecedente familiar de alergias influye en la probabilidad de que un niño desarrolle alergia alimentaria? A. Aumenta la probabilidad B. No influye en nada C. Disminuye la probabilidad D. No conozco 5. ¿Cuál de los siguientes alimentos considera usted que es uno de los principales causantes de alergias en niños? A. Arroz B. Leche de vaca C. Pollo D. No conozco 6. ¿Qué alimentos considera usted que causan alergias alimentarias? A. Leche, huevo, maní, nueces, pescado, mariscos, trigo y soya B. Leche, pollo, arroz, lentejas, manzana, papa, carne de res y avena C. Yogurt, fideos, zanahoria, brócoli, palta, pollo, arveja y camote D. No conozco
2. Signos y síntomas	Identificación de síntomas cutáneos	7. ¿Cuál considera usted que es un signo común de una alergia alimentaria en los niños?

	• Identificación de síntomas gastrointestinales • Identificación de síntomas respiratorios • Reconocimiento de signos de anafilaxia • Conocimientos de medidas preventivas	A. Fiebre alta B. Dolor en los huesos C. Ronchas en la piel D. No conozco 8. Si un niño presenta hinchazón en los labios después de comer nueces, ¿qué considera usted que esto puede indicar?: A. Un problema de caries dental B. Una reacción alérgica alimentaria C. La falta de vitaminas importantes D. No conozco 9. ¿Qué síntoma digestivo cree usted puede estar relacionado con una alergia alimentaria? A. Dolor de espalda muy fuerte B. Resfrío frecuente acompañado de fiebre C. Vómitos o diarrea después de comer D. No conozco 10. Usted cree que una reacción alérgica alimentaria en el niño se puede manifestar con signos en la piel como: A. Piel reseca por el frío B. Ronchas o enrojecimiento
--	---	--

		C. Lunares nuevos D. No conozco 11. Usted considera que una reacción alérgica alimentaria en el niño puede afectar la respiración manifestándose como: A. Tos seca ocasional B. Dolor de garganta C. Dificultad para respirar D. No conozco 12. Si un niño presenta hinchazón en la cara, lengua o labios de comer pescado, ¿qué cree usted que esto podría significar?: A. Solo un golpe o raspón leve B. Una reacción alérgica grave C. Ganas de dormir o cansancio D. No conozco 13. Usted considera que uno de los signos graves de alergia alimentaria se manifiesta por: A. Somnolencia prolongada durante el día B. Dificultad para respirar y desmayo C. Dolor en las articulaciones después de comer D. No conozco
--	--	--

		14. ¿Qué medida preventiva cree usted que puede ayudar a los cuidadores a reconocer los síntomas tempranos? A. Vigilar los cambios en la piel, respiración o digestión después de comer B. No observar lo que come el niño ni prestar atención a sus reacciones C. Dar cualquier comida que el niño pida sin control ni supervisión de un adulto D. No conozco 15. Para prevenir alergias alimentarias en un niño pequeño, ¿Qué considera usted que es importante realizar?: A. Introducir los alimentos nuevos de uno en uno y observar la reacción B. Ofrecer muchos alimentos diferentes al mismo tiempo sin esperar la reacción C. Evitar la lactancia materna y reemplazarla por otros alimentos sólidos D. No conozco 16. La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses aporta múltiples beneficios para la salud y el desarrollo del niño. ¿Cuál considera usted que es uno de estos beneficios principales? A. Aumentar el sueño del bebé durante ciertos momentos del día
--	--	---

		B. Proteger contra el desarrollo de alergias alimentarias C. Evitar completamente todas las enfermedades de la infancia D. No conozco
--	--	--

ANEXO 3: CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

$$n = \frac{N \times Z^2 \times p \times q}{e^2(N - 1) + Z^2 \times p \times q}$$

$$n = 242 \text{ cuidadores}$$

Donde:

- **N** = 654 (población)
- **Z** = 1.96 (95% confianza)
- **p** = 0.5
- **q** = 0.5
- **e** = 0.05 (5% error)

ANEXO 4: CUESTIONARIO

I. PRESENTACIÓN

Estimado(a) participante:

Buen día, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Diana Katherine Ramos Vásquez, estudiante de la carrera profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Usted ha sido seleccionado(a) para participar voluntariamente en esta investigación titulada: **“Conocimientos sobre el desarrollo de alergias alimentarias en cuidadores de niños de 6 a 24 meses”** cuyo propósito es identificar el nivel de conocimientos que poseen los cuidadores sobre los alimentos alergénicos, los signos y síntomas y medidas preventivas asociadas a las reacciones alérgicas en la infancia temprana.

Su participación es confidencial y anónima. No existen respuestas buenas o malas; por favor, responda con sinceridad. Sus respuestas serán utilizadas únicamente con fines académicos.

Agradecemos de antemano su colaboración.

II. DATOS GENERALES

- Edad: _____ años
- Sexo: ☐ Femenino ☐ Masculino
- Procedencia: ☐ Costa ☐ Sierra ☐ Selva ☐ Otro
- Nivel educativo:
 - ☐ Primaria
 - ☐ Secundaria
 - ☐ Estudios universitarios
- Parentesco con el niño(a):
 - ☐ Madre ☐ Padre ☐ Otro: _____

III. INSTRUCCIONES

A continuación, encontrará una lista de enunciados que deberá leer atentamente y marcar con una "X" la alternativa que considere más apropiada. El cuestionario tiene una duración aproximada de 15 minutos.

IV. DATOS ESPECÍFICOS

Sección 1: Conocimiento sobre alimentos alergénicos

1. Usted considera que una alergia alimentaria se define como:
 - A. Una infección que se presenta en el estómago por algunos alimentos
 - B. Una reacción del sistema inmunológico frente a ciertos alimentos**
 - C. Un problema que ocurre al digerir determinados tipos de alimentos
 - D. No conozco
2. Cuando un niño tiene alergias alimentarias, cree usted que se manifiesta por:
 - A. Solo siente un poco de hambre, cansancio y sueño en algunos momentos
 - B. Puede presentar síntomas como ronchas, vómitos o dificultad para respirar**
 - C. Puede presentar molestias leves que parecen poco importantes
 - D. No conozco
3. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que se asocia más frecuentemente al desarrollo de alergias alimentarias?
 - A. El clima de la región donde vive habitualmente el niño
 - B. El nivel de actividad física que realiza diariamente el niño
 - C. La predisposición genética y antecedentes familiares**
 - D. No conozco
4. ¿Cree usted que el antecedente familiar de alergias influye en la probabilidad de que un niño desarrolle alergia alimentaria?
 - A. Aumenta la probabilidad**
 - B. No influye en nada
 - C. Disminuye la probabilidad
 - D. No conozco

5. ¿Cuál de los siguientes alimentos considera usted que es uno de los principales causantes de alergias en niños?

A. Arroz

B. Leche de vaca

C. Pollo

D. No conozco

6. ¿Qué alimentos considera usted que causan alergias alimentarias?

A. Leche, huevo, maní, nueces, pescado, mariscos, trigo y soya

B. Leche, pollo, arroz, lentejas, manzana, papa, carne de res y avena

C. Yogurt, fideos, zanahoria, brócoli, palta, pollo, arveja y camote

D. No conozco

Sección 2: Conocimientos sobre signos y síntomas

7. ¿Cuál considera usted que es un signo común de una alergia alimentaria en los niños?

A. Fiebre alta

B. Dolor en los huesos

C. Ronchas en la piel

D. No conozco

8. Si un niño presenta hinchazón en los labios después de comer nueces, ¿qué considera usted que esto puede indicar?:

A. Un problema de caries dental

B. Una reacción alérgica alimentaria

C. La falta de vitaminas importantes

D. No conozco

9. ¿Qué síntoma digestivo cree usted puede estar relacionado con una alergia alimentaria?

- A. Dolor de espalda muy fuerte
- B. Resfrío frecuente acompañado de fiebre
- C. Vómitos o diarrea después de comer**
- D. No conozco

10. Usted cree que una reacción alérgica alimentaria en el niño se puede manifestar con signos en la piel como:

- A. Piel reseca por el frío
- B. Ronchas o enrojecimiento**
- C. Lunares nuevos
- D. No conozco

11. Usted considera que una reacción alérgica alimentaria en el niño puede afectar la respiración manifestándose como:

- A. Tos seca ocasional
- B. Dolor de garganta
- C. Dificultad para respirar**
- D. No conozco

12. Si un niño presenta hinchazón en la cara, lengua o labios de comer pescado, ¿qué cree usted que esto podría significar?:

- A. Solo un golpe o raspón leve
- B. Una reacción alérgica grave**
- C. Ganas de dormir o cansancio
- D. No conozco

13. Usted considera que uno de los signos graves de alergia alimentaria se manifiesta por:

A. Somnolencia prolongada durante el día

B. Dificultad para respirar y desmayo

C. Dolor en las articulaciones después de comer

D. No conozco

14. ¿Qué medida preventiva cree usted que puede ayudar a los cuidadores a reconocer los síntomas tempranos?

A. Vigilar los cambios en la piel, respiración o digestión después de comer

B. No observar lo que come el niño ni prestar atención a sus reacciones

C. Dar cualquier comida que el niño pida sin control ni supervisión de un adulto

D. No conozco

15. Para prevenir alergias alimentarias en un niño pequeño, ¿Qué considera usted que es importante realizar?:

A. Introducir los alimentos nuevos de uno en uno y observar la reacción

B. Ofrecer muchos alimentos diferentes al mismo tiempo sin esperar la reacción

C. Evitar la lactancia materna y reemplazarla por otros alimentos sólidos

D. No conozco

16. La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses aporta múltiples beneficios para la salud y el desarrollo del niño. ¿Cuál considera usted que es uno de estos beneficios

principales?

A. Aumentar el sueño del bebé durante ciertos momentos del día

B. Proteger contra el desarrollo de alergias alimentarias

C. Evitar completamente todas las enfermedades de la infancia

D. No conozco

¡Muchas gracias por su participación!

ANEXO 5: CÁLCULO DE LOS VALORES FINALES DE LA VARIABLE

Método de máximos y mínimos

N° de preguntas: 16

$$\text{Máximos} = (\#preg)(1) = (16)(1) = 16$$

$$\text{Mínimos} = (\#preg)(0) = (16)(0) = 0$$

Cálculo del rango dividido en 3:

$$(\text{Máx} - \text{Mín}) / 3 = (16 - 0) / 3 = 5.3$$

Valor final de la variable:

$$\text{Alto: } (11 - 16)$$

$$\text{Medio: } (6 - 10)$$

$$\text{Bajo: } (0 - 5)$$

ANEXO 6: CONSENTIMIENTO INFORMADO

Actualmente, las alergias alimentarias representan un problema creciente de salud pública, especialmente en la población infantil menor de dos años. Si bien existen medidas de prevención, detección y manejo temprano, en muchos casos el desconocimiento de los cuidadores puede dificultar una intervención oportuna. En ese contexto, se está llevando a cabo el presente estudio titulado: **“Conocimientos sobre alergias alimentarias en cuidadores de niños de 6 a 24 meses en el Centro de Salud San Luis, 2026.”**

Con su participación voluntaria, usted contribuye al desarrollo del conocimiento científico en salud, en especial sobre el nivel de información que tienen los cuidadores acerca de las alergias alimentarias, sus síntomas, alimentos desencadenantes y medidas de prevención. Su aporte permitirá identificar oportunidades de mejora en la educación alimentaria y en la atención primaria pediátrica.

La participación consiste en responder un cuestionario anónimo, lo que tomará aproximadamente 15 minutos. El cuestionario no tiene respuestas correctas o incorrectas, y su propósito no es evaluativo, sino informativo. El estudio no implica ningún riesgo para usted ni para su menor hijo(a), tampoco supone ningún costo económico. La información brindada será tratada con absoluta confidencialidad y se utilizará únicamente con fines académicos. En ningún momento se solicitará su nombre ni otros datos personales que permitan identificarle, y los resultados serán presentados de manera general.

Habiendo recibido la información sobre el propósito, objetivo y características del estudio, y estando plenamente informada sobre la confidencialidad de los datos y la ausencia de riesgos o consecuencias negativas, usted decide participar de manera libre y voluntaria. Asimismo, comprende que puede retirarse del estudio en cualquier momento, sin que ello le ocasione ninguna penalidad ni afecte la atención de salud de su menor hijo(a).

HE LEÍDO Y COMPRENDIDO. HE QUEDADO SATISFECHO. MIS
PREGUNTAS HAN SIDO RESPONDIDAS.

YO, VOLUNTARIAMENTE, PERMITO LA PARTICIPACIÓN DE MI MENOR
HIJO EN EL ESTUDIO.

Lima, _____ de _____ de 2026.

Firma de la participante: _____

DNI: _____

ANEXO 7: COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO

COEFICIENTE DE VALIDEZ DE CONTENIDO (CVC)

(Hernandez-Nieto, 2011)

3 JUECES

Item	J1	j2	j3	Σx_{ij}	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	3	4	5	12	4.0000	0.8000	0.0370	0.7630
2	3	3	5	11	3.6667	0.7333	0.0370	0.6963
3	4	3	5	12	4.0000	0.8000	0.0370	0.7630
4	4	3	5	12	4.0000	0.8000	0.0370	0.7630
5	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
6	3	4	4	11	3.6667	0.7333	0.0370	0.6963
7	3	4	5	12	4.0000	0.8000	0.0370	0.7630
8	3	5	5	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
9	3	4	3	10	3.3333	0.6667	0.0370	0.6297
10	3	4	5	12	4.0000	0.8000	0.0370	0.7630
11	3	5	5	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
12	3	5	5	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
13	3	4	5	12	4.0000	0.8000	0.0370	0.7630
14	3	4	3	10	3.3333	0.6667	0.0370	0.6297
15	4	4	5	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
16	3	4	5	12	4.0000	0.8000	0.0370	0.7630

Σ 12.2747

n de ítems	16	CVCt	0.7672
		CVCtc	0.7302

Item	J1	j2	j3	Σx_{ij}	(Mx)	CVCi	Pei	CVCic
1	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
2	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
3	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
4	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
5	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
6	3	5	5	13	4.3333	0.8667	0.0370	0.8297
7	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
8	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
9	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
10	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
11	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
12	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
13	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
14	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963
15	5	5	5	15	5.0000	1.0000	0.0370	0.9630
16	4	5	5	14	4.6667	0.9333	0.0370	0.8963

Σ 14.4080

n de items	16	CVCt	0.9005
		CVCtc	0.8635

CVC = 0.7968



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA
FACULTAD DE MEDICINA



ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Lima 05 de noviembre del 2025

CARTA N°0170-EPE-FM-2025

Dr.

PEDRO ALEJANDRO CRUZADO PUENTES

Director

DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD - DIRIS LIMA CENTRO

De mi consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle y a la vez, manifestarle que la estudiante de la Escuela Profesional de Enfermería:

- **Srta. Ramos Vásquez Diana Katherine**, identificada con número de DNI N° **70401142**

La cual viene desarrollando su proyecto de investigación:

"CONOCIMIENTOS SOBRE ALERGIAS ALIMENTARIAS EN CUIDADORES DE NIÑOS DE 6 A 24 MESES EN CENTRO DE SALUD DE LIMA, 2025"

En tal sentido, se solicita muy amablemente brinde usted o autorice a quien corresponda las facilidades necesarias para que la mencionada estudiante pueda recolectar información y aplicar su instrumento durante los meses de noviembre a diciembre del 2025.

Sin otro particular y agradeciéndole anticipadamente por todas las facilidades que brinde, me despido de usted.

Muy Atentamente.

DRA. JUANA MAILDE CUBA SANCHO
Directora
Escuela Profesional de Enfermería
UNMSM



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE MEDICINA
INSTITUTO DE ÉTICA EN SALUD
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN

“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana”



ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO DE ESTUDIO N°: 0348-2025

En Lima, a los veintiuno días del mes de octubre, en Sesión del COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, previa evaluación del Proyecto de Investigación titulado: “**Conocimientos sobre alergias alimentarias en cuidadores de niños de 6 a 24 meses en un centro de salud de Lima, 2025**” presentada por **Diana Katherine Ramos Vásquez** con código 22010145, de la escuela profesional de enfermería, proyecto de investigación para ser ejecutado en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ACUERDA:

Dar por **APROBADO** dicho Proyecto, considerando que se ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones en aspectos Científicos Técnicos y Éticos para la investigación en seres humanos.

“El presente documento tiene vigencia a partir de la fecha y expira el 20 de octubre de 2026”

Lima, 21 de octubre de 2025



JUAN CARLOS OCAMPO ZEGARRA
PRESIDENTE DEL C.E.I. / F.M. / U.N.M.S.M.
FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO
CODIGO DOCENTE: 0A3079
CMP: 043040 - RNE: 028980 - RNSE: S00415

Dr. Juan Carlos Ocampo Zegarra
Presidente del CEI/FM/UNMSM